

50mg,硝普钠每分钟6~8滴的起效时间,作用强度大致相同。硝酸甘油组用药1h内,以原有高血压降至正常值约有60%,4.5~5h血压平稳在16/12kPa;硝普钠组用药1h内从原有高血压降至正常值约有58%,但5~5.5h血压平稳在16/12kPa。而且,血压波动幅度较大,常见偏低于正常值。

7例基底节血肿的病人,用硝酸甘油后,3~7d内复查头颅CT未见血肿增大,出血等。13例破入脑室的脑出血病人,除3例病情危重不能检查外,余10例均于4或8d内复查头颅CT未见血肿增大或出血。

静滴硝酸甘油控制血压后,再配合口服或鼻饲降压药,如心痛定、开搏通等,可稳定血压防止再升高。

3. 讨论:高血压脑出血后,病人持续性血压增高,用硝普钠、硝酸甘油均有作用,但硝酸甘油降压平稳,作用持久,不需避光设备,静滴数控制不太严格,而且临床观察硝酸甘油应用后,复查头颅CT未见术腔有再出血情况,说明硝酸甘油在高血压脑出血后病人应用安全,且价格便宜,使用方便。由于以上特点,硝酸甘油适用于缺少心电监护设备的单位使用。对孕妇、高龄、肾功能不全、有冠心病的病人都可使用。在静滴降压药物的同时,清醒的病人要口服降压药,不能吞咽或不清醒的病人要鼻饲降压药片,以稳定血压,防止血压再升高很有必要。

药物相互作用初探

陈 继 覃

(厦门市药品检验所)

游 枫 慧

(福建医科大学附属协和医院)

医药科学的不断发展,新药的不断增加,医院用药千种以上。实践证明,对药物相互作用问题,应给予十分重视。

1. 临床表现:1.1 某些药物给药方式可致化学与物理的配伍禁忌,例如,氨基糖甙类抗菌素注射前若与青霉素混合,易使一种抗菌素灭活另一种抗菌素;甲氧苄青霉素在同一溶液内易被卡那霉素灭活;庆大易被氯苄和苄青霉素灭活;还有一些药物制剂一旦被加到与注射液本身最适pH有显著差异的输液中就可导致游离酸、硷产生,出现沉淀,使药物分解。1.2 药动学方面的相互作用。相互作用结果

或加强或减弱;甲氧苄胺嘧啶可使磺胺类药物增效,并可克服微生物耐药性;阿托品可抵消吗啡的平滑肌收缩作用,并增强内脏器官的镇痛作用。普鲁卡因与叶酸可降低磺胺的药效;胃复安与阿托品合用,相互抵消作用,速尿强利尿药可增强氨基糖甙类抗生素的耳毒性。1.3 与血浆蛋白结合的相互作用。许多药物在体内与血浆蛋白结合,当药物与血浆蛋白结合便暂时失去活性,只有处于游离状态的药物才具有活性,游离型与结合型药物之间处于可逆的平衡。列举几种药物蛋白结合率,氨基比林15%,苯巴比妥20%,消炎痛90%,华法令95%、甲苯磺丁脲95%。如双香豆素类抗凝剂血浆蛋白结合率为98%,非结合率只为2%起抗凝部分,因而只要置换小部分就会使患者大出血,又如具有高血浆蛋白结合率的抗凝药华法令是一个弱酸性药物,被弱酸性抗炎药保泰松、甲灭酸置换出来,由于华法令游离药量增加而导致出血。1.4 酶促作用。由于某些药物具有诱导药物代谢酶,使其活性加强,因此就可以使另外一些药物代谢速度加快,迅速灭活失效。巴比妥类、水合氯醛、导眠能、眠而通、保泰松、安体舒通、利福平具有酶促作用。如长期服用巴比妥类药物,产生耐药性而需不断加大剂量,这是巴比妥类药物增强了代谢酶,使其代谢加快,抗癫痫药扑痫酮、美索因、苯巴比妥与强力霉素合用,强力霉素半衰期由15.1h→7.2h,使长效变短效,长期服用苯巴比妥与苯妥英钠患者,易出现骨质软化或钙代谢障碍,因为药物酶促作用使Vit. D的代谢结果增强。1.5 酶抑制作用。一些药物通过抑制酶而使另一些药物代谢延迟,作用加强,同时毒性及副作用也加强。氯霉素与口服降糖药、口服抗凝药、苯妥英钠合用,半衰期延长,氯霉素可提高D860半衰期一半,可使苯妥英钠血浓度提高4~5倍,除抑制药酶外,尚有氯霉素在肠道中抑制Vit K₃合成或加强出血的倾向;异烟肼与PAS合用,两者在抗结核杆菌方面起协同作用,由于PAS抑制异烟肼的代谢,使异烟肼血浓度提高,抗菌作用加强,但引起周围神经炎可能性也相应加大。1.6 药效学方面的相互作用。药物通常通过受体结合而产生效应,药物之间阻断受体或竞争受体都可影响药效,或增加药效或减弱药效。氨基糖甙类抗菌素与肌肉松弛剂并用使肌肉松弛引起呼吸困难,甚至呼吸停止,因肌肉松弛剂与乙酰胆硷受体结合后,阻断了乙酰胆硷与受体结合的神经——肌肉接头产生去极化作用,使骨骼肌松弛。另心得安与利血平合用应密切观察心脏活动,因利血平能耗竭心肌的儿茶酚胺(介质)而心得安对心肌的β受体阻断,两者都明

显抑制心脏活动,心率过度减慢;由于药物相互作用,影响介质的生成或加速介质的灭活或阻断介质的释放均直接影响药物的疗效;利尿酸、速尿、强效利尿药具有耳毒性,若与氨基糖甙类抗菌素合用时,耳毒性加重。同样两种氨基糖甙类抗菌素并用,则听神经毒性↑。其它非激素类解热镇痛药与阿司匹林等合用,均可抑制前列腺,加重溃疡出现。氯丙嗪、度冷丁、氟哌啶醇合用,增强麻醉效应,也增强中枢的抑制;噻嗪类、利尿剂、利尿酸与速尿合用,改变电解质的平衡,造成大量钾失去,可的松有贮钠排钾作用,若与双氢克尿塞合用,易引起低钾血症。

2. 方法:输液混合物的研究往往在不同条件下进行,而且研究目的也常不相同。进行这项研究时可用小量、浓度适宜的肌肉注射液。在一个小注射液容器内进行,混合后溶液若立即发生沉淀则说明此混合液不能配伍。然而这个被认为配伍禁忌的药物与输液在一定条件下也许就成为稳定,也能配伍了。如将两溶液主份分别稀释后再混合,则不会出现沉淀,因此必须清楚,浓度是个易变的因素。还有其它因素如药物混合的顺序、接触时间、pH 值和输液本身性质等。如静脉脂肪乳剂是靠物理力的微弱平衡达到稳定的制剂代表,这类乳剂易被添加剂破坏,一旦稳定性被破坏就可能造成血管栓塞的危险;注射用氨基酸制剂与β内酰胺类混合可形成免疫原与过敏原结合物;对药物的相互作用进一步研究,是采用目测法还是可靠的分析方法甚为重要。要根据不同药物,采用不同分析方法准确测定。但由于生产厂家不同,配方差异,相互作用可能不同,药师要善于从许多文献报道中筛选有用的参考资料,加以准确测定研究,得到正确的结论。

3. 讨论:3.1 药物相互作用不仅受本身质与量的影响且受机体各种状态,特别是精神状态的影响,要根据病人不同的年龄、性别、个体差异来选择用药,做到因人施药,辨证论治。3.2 药物相互作用不仅受到药物吸收速率,病人现状的影响,还受到给药途径不同的影响,因此要依据口服、直肠、舌下、注射

的不同区别对待。3.3 药物相互作用不仅有许多复杂过程,还包括许多环节问题,要根据直接作用和间接作用的不同加以区别,做到全面掌握,合理用药。

随着临床药学的发展,药物动力学、药效学、生物药剂学的深入研究,药物相互作用的实际与理论,给临床合理用药打下了坚实的基础,发挥了指导用药的特殊功用。

(参考文献略)

倍他乐克治疗妇女更年期心血管综合征40例疗效观察

卞娟维 王振贞 严宗霖
(福州市第一医院)

我们应用倍他乐克治疗妇女更年期心血管综合征40例,以更年期康作为对照治疗20例,现报告如下。

1. 一般资料:几年来我们收集60例患者均系在更年期中出现以血管运动神经功能紊乱,如潮热、烦躁不安、胸闷、心悸、气促、头晕、头痛等症者,随来诊顺序2:1,随机分为治疗组40例,年龄43~56岁,平均49.4岁,对照组20例,44~56岁,平均49.8岁。两组年龄、血压心率等均具可比性。

2. 治疗方法:治疗组,以倍他乐克50mg 每日1次晨服,血压>18.7/12.0kPa 者每日早晚各1次口服。对照组以更年期康口服,每次3片,每日3次。1疗程皆为2周,连服3~4疗程,治疗中除加用谷维素、维生素B₁、B₆、E 外,不再加用其它药。

3. 疗效评定:显效:临床主要症状基本消失,早搏消失,血压复常。有效:症状减轻,早搏减少,血压复常或接近正常。无效:症状、体征无变化或加重。

4. 结果:两组治疗效果(见表1)。两组总疗效经Ridit 分析无显著性差异(P>0.05)。两组治疗前后血压,心率的变化(见表2)。

表1 两组治疗结果比较

组别	例数	显效 例数(%)	有效 例数(%)	无效 例数(%)	总有效 例数(%)	$\bar{R}$	组间P
治疗组	40	28(70.00)	9(22.50)	3(7.50)	37(92.50)	0.6381	
对照组	20	9(45.00)	8(40.00)	3(15.00)	17(85.00)	0.5000	>0.05